

Endocrinologie QCM

Variante 1:

1* - Les lésions non-tumorales qui peuvent déterminer un syndrome tumoral hypophysaire sont les suivantes avec une exception :

- a. Les vestiges de la poche de Rathke
- b. Les abcès hypophysaire
- c. Les kystes arachnoïdiens
- d. Les granulomes hypophysaires
- e. La sarcoïdose

REP: A (p.10)

2*- La calcitonine :

- a. Est sécrétée par les glandes parathyroïde
- b. Est sécrétée par les cellules C parafolliculaires thyroïdiennes
- c. Est sécrétée par les cellules folliculaires thyroïdiennes
- d. Est élevée dans l'hyperparathyroïdie primaire
- e. Est sécrétée par les thyrocytes

REP: B

3*- Le signe clinique évocateur d'un phéochromocytome est :

- a. La prise de poids
- b. L'atrophie musculaire
- c. Les troubles digestifs
- d. La mélanodermie
- e. L'hypertension artérielle paroxystique

REP: E

4*-La cause la plus fréquente du mort dans l'acromégalie est :

- a. L'extension tumorale
- b. L'insuffisance cardiaque
- c. L'hypertension artérielle
- d. La cardiomyopathie
- e. Le diabète sucré

REP: B (p.26)

5*-Le trouble de rythme révélateur de l'hyperthyroïdie est

- a. Le flutter
- b. La tachysystolie
- c. La fibrillation auriculaire
- d. La tachycardie sinusale
- e. La tachycardie supraventriculaire paroxystique

REP: C (p.56)

6*- La ... est le signe clinique de:

- a. L'insuffisance surrénalienne aiguë
- b. La maladie d'Addison
- c. Le syndrome de Cushing
- d. L'hypothyroïdie
- e. L'insuffisance parathyroïdienne

7*- l'hypophyse antérieure synthétise les suivantes hormones avec une exception

- a. GH
- b. TSH
- c. CRH
- d. FSH ET LH
- e. PROLACTINE

REP: C

8*- Le rétrocontrôle de la sécrétion de PTH est réalisé par

- a. Le calcitonine
- b. Le niveau de la calcémie
- c. Le TSH
- d. La phosphorémie
- e. Le niveau de la vitamine D

REP: B

9*- Parmi les suivants qui NE représente PAS un facteur de risque pour l'ostéoporose

- a. L'indice de masse corporelle bas
- b. Le tabagisme
- c. L'abus d'alcool
- d. L'immobilisation
- e. Le stress

REP: E (p.102)

10*- la cause plus fréquente de la forme ACTH indépendante du syndrome de Cushing est :

- a. L'adénome
- b. Hyperplasie macronodulaire bilatérale
- c. Hyperplasie micronodulaire pigmentaire
- d. La corticothérapie
- e. Le corticosurrénalome

Rep: D (p.108)

11- le risque évolutif dans l'hyperthyroïdie est représenté par

- a. L'adénocarcinome
- b. L'insuffisance rénale
- c. Cardiothyroïdose
- d. La crise aiguë thyrotoxique
- e. L'ostéoporose

REP: CDE (p.52) => + diabète + hépatose

12- l'hyperthyroïdie iodo induit est produit par le :

- a. Opiacés
- b. Mé??
- c. ..
- d. Amiodarone
- e. Produits de contraste



28- Le traitement de l'hyperparathyroïdie secondaire comprend :

- a. L'augmentation des apports protidiques
- b. La chélation intestinale de l'hyperphosphorémie avec gluconate de calcium
- c. L'apport de calcium
- d. L'apport des dérivés actifs de la vitamine D
- e. La réduction parathyroïdienne

REP: BCDE (p.93)

29- les éléments du syndrome tumoral hypophysaire sont :

- a. La stase musculaire
- b. La tachycardie
- c. Les signes d'insuffisance hypophysaire
- d. Les crises convulsives
- e. Les vomissements



30- les complications de l'hypothyroïdie sont dominées par :

- a. Les troubles du rythme
- b. L'insuffisance cardiaque
- c. L'ophtalmopathie
- d. Le coma myxoédémateux
- e. Les accidents coronariens



31- les inconvénients du traitement avec l'iode radioactif sont :

- a. L'efficacité lente
- b. La simplicité
- c. Le coût faible
- d. L'hypothyroïdie tardive
- e. L'efficacité ra ide



32- la thyroïdite lymphocytaire

- a- Est d'origine auto-immune
- b- Est fréquemment précédée d'un syndrome grippal
- c- Est évoqué par un syndrome douloureux de la région cervicale
- d- A comme signe clinique un goitre diffus de consistance ferme indolore
- e- A comme signe biologique essentiel la présence de titres très élevés d'anticorps anti-microsomes thyroïdiens



35- Les causes d'hypothyroïdie du nouveau-né sont:

- a-
- b- La thyroïdite de Riedel
- c-
- d- sarcoidose
- e- Car

36- Ces médicaments inhibent la conversion périphérique de T4 ou T3 ?

- a- Les glucocorticoïdes
- b- Les sédatifs
- c- Les Antithyroïdiens de synthèse
- d- Propranolol
- e-

37- L'iode radioactif a comme indication :

- a. L'adénome toxique
- b. La maladie de Basedow
- c. L'hyperthyroïdie iodo-induite
- d. La crise aiguë thyroïdienne
- e. La goitre multihétéronodulaire toxique

REP: ABE (p.58 et 61)

38- le myxoedème pré tibial

- a. Consiste à placards rouges et tuméfiés au niveau des cuisses
- b. Est un signe étiologique en faveur d'une thyroïdite chronique de Hashimoto
- c. Consistè à placards rouges au niveau des jambes
- d. Est un signe étiologique en faveur d'une maladie de Basedow
- e. A comme traitement les diurétiques

REP: CD (p.55)

39- Le traitement médical de l'hyperprolactinémie comprend

- a. Minirin
- b. Bromocriptine
- c. Sandostatine
- d. Parlodel
- e. Cabergoline

REP: BE

40- la pathologie des corticosurrénales est représentée par :

- a. La maladie d'Addison
- b. Le syndrome de Cushing
- c. L'incidentalome hypophysaire
- d. Le phéochromocytome
- e. Le myxoedème

REP: ABD => Phéochromocytome = origine médullosurrénale ?oui

41- Le traitement des substitutions minéralocorticoïde avec Fludrocortisone :

- a. Est utilisée dans l'insuffisance surrénalienne secondaire
- b. Est représenté par Astonin H
- c. Nécessite un régime alimentaire normalement salé
- d. Est utilisé dans l'insuffisance hypophysaire corticotrope
- e. Est utilisée dans la maladie d'Addison

REP: BCE (p.130)

42- la scintigraphie a comme contre-indications :

- a. Le traitement avec antithyroïdiens de synthèse
- b. La surcharge iodée
- c. La grossesse
- d. Le traitement avec hormones thyroïdiennes
- e. Le traitement avec thyroxine

REP: BCDE (p.48)

43- le système rénine angiotensine

- a. Est produit dans la glande surrénale
- b. Intervient dans le contrôle de la zone glomérulée des corticosurrénales
- c. Contrôle la sécrétion des hormones minéralocorticoïde
- d. contrôle la sécrétion de cortisol
- e. contrôle la production d'aldostérone

REP: BCE

44- le neurohypophyse contient

- a. l'hormone de croissance
- b. la prolactine
- c. l'hormone antidiurétique
- d. la vasopressine
- e. l'ocytocine

REP: CDE

45- Les hyperprolactinémies organiques ont les suivantes étiologiques :

- a. les adénomes neurohypophysaires
- b. le stress
- c. les lésions hypothalamiques
- d. la grossesse
- e. les tumeurs développées à partir des cellules à prolactine

REP: BCDE (p.15)

46- L'hyperkaliémie peut être causée par

- a. L'insuffisance surrénalienne aiguë sur la maladie d'Addison
- b. L'insuffisance surrénalienne secondaire
- c. Le syndrome de Cushing
- d. La corticothérapie
- e. L'insuffisance surrénalienne primitive

REP: AE (p.129 et 134)

47- le traitement glucocorticoïde

- a. est utilisé dans les formes sévères des hyperthyroïdies iode-induites
- b. stimule la conversion périphérique de la T4 en T3
- c. inhibe la conversion périphérique de la T3 en T4
- d. est essentiel dans la maladie d'Addison
- e. peut induire une insuffisance corticotrope

REP: ADE (p.60)

48- la TSH

- a. est une hormone polypeptidique
- b. est diminué en hypothyroïdie
- c. est élevée en hyperthyroïdie
- d. est élevée en hypothyroïdie
- e. est diminuée en hyperthyroïdie

REP: DE (p.1) => la TSH est une glycoprotéine

49-le syndrome de faux Cushing est cause par

- a. la contraception
- b. le cancer
- c. l'alcoolisme
- d. la corticothérapie
- e. l'obésité

REP: CE (p.109)

50-l'ostéoporose

- a. a comme facteur de risque l'activité physique
- b. comprend comme méthodes de traitement les estrogènes
- c. peut être causée par les corticosurrénales
- d. est définie par le score T en moins de 2.5
- e- A comme objectif thérapeutique l'augmentation du turnover osseux

REP: BCD (p.102)

Variante 4

1* Les critères échographique de malignités des nodules thyroïdiens sont :

A- Formation vasculaire centrale

B- halo présent

C- formation cristique

D- lésion hyperéchogène

E- Absence de la mobilité par rapport aux plans sous et supra-jacents

REP: A

2* Les hypocalcémies parathyroïdiennes sont déterminées par les suivantes , avec une exception :

A- Primaires

B- Chirurgicales

C- Idiopathiques

D- Fonctionnelles

E- Néonatales

REP: A

3* Lequel des suivants cancers thyroïdiens a le meilleur pronostic clinique :

A- Papillaire

B- Médullaire

C- Anaplasique

D- Lymphome

E- Tumeur à cellules Hurthle

REP: A

4* Parmi les affirmations suivantes laquelle n'apparaît pas à l'acromégalie :

A- Syndrome de canal carpien

B- HTA

C- Viscéromégalie

D- Hyperhidrose

E- Hypercalcémie

REP: E

5* Les hormones hypophysaires sont les suivants , avec l'exception de :

A- LH

B- FSH

C- TSH

D- PTH

E- ACTH

REP: D

6* Les aspects cliniques qui laissent penser à la malignité des nodules thyroïdiens sont les suivants à l'exception de :

A- Croissance rapide

B- Consistance élevée

C- Sexe masculin

D- Historique de l'irradiation pendant l'enfance ou l'adolescence

E- Volume thyroïdien agrandi

REP: C

7* Le signe clinique de l'insuffisance corticotrope est :

- A- L'agalactie
- B- La stérilité
- C- La dépilation axillaire
- D- La frilosité
- E- L'hypotension artérielle

REP: E (p.35)

8* Pour le diagnostic de l'ostéoporose , on prend en considération :

- A- Score T entre -1 et +1
- B- Score T entre -1 et +1.5
- C- Score T supérieur -2.5
- D- Score T entre -2.5 et -4
- E- Score T entre -1 et -2.5

REP: D

9* Les effets métaboliques du cortisol sont :

- A- L'augmentation de l'absorption intestinale du glucose
- B- Un effet lipolytique
- C- Un Rôle anabolisant protéique
- D- En dose supra-physiologique inhibe le catabolisme protéique
- E- Augmente la sécrétion de l'insuline

REP: B

10* Laquelle parmi les suivantes représente la cause de l'insuffisance corticosurrénale secondaire :

- A- Auto-immune
- B- Infections
- C- Interruptions brusques de corticoïdes
- D- Maladies infiltratives
- E- Métastase

REP: C

11- Les causes du diabète insipide néphrogène sont :

- A- Pyélonéphrite chronique
- B- Potomanie
- C- Carence de cortisol
- D- Amyloïdose
- E- Régime hyposodé

REP: ABD

12- Les examens radiologiques dans l'hyperparathyroïdisme primaire peuvent montrer les lésions osseuses suivantes :

- A- Tassement vertébrale
- B- Au niveau des gros os de main – une déminéralisation des épiphyses
- C- Au niveau des petits os – des kystes osseux
- D- Des tumeurs myéloplaxes apparaît à la surface des os longs
- E- Le crâne apparaît hyperminéralisé

REP: ABC

13- Dans l'adénome somatotrope :

- A- Le dosage GH est le meilleur test de screening
- B- Le GH basale a une valeur élevée
- C- La prolactine a parfois une valeur un peu élevée
- D- Des autres hormones hypophysaires ont des fois des valeurs élevées
- E- Le dosage IGF-1 est le meilleur test de screening

REP: BCE

14- Paraclinique dans l'insuffisance pituitaire chez enfant :

- A- Le GH est élevée réactive
- B- Le GH est bas
- C- IGF-1 est bas
- D- Une hypoglycémie apparaît spontanément
- E- Une hyperglycémie apparaît spontanément

REP: BCD

15- Diabète insipide néphrogène :

- A- Apparaît suite à un niveau bas de l'ADH circulant
- B- Apparaît suite à un niveau bas de l'ACTH circulant
- C- A pour cause des maladies rénales chroniques
- D- Se manifeste avec des troubles électrolytiques
- E- Se manifeste pas anurie

REP: CD

16- Le traitement dans l'insuffisance antéro hypophysaire globale chez l'adulte consiste à :

- A- Traitement pluri hormonal
- B- Administration de l'hydrocortisone ou prednisone
- C- Hormones thyroïdiennes
- D- Bromocriptine
- E- Insuline

REP: ABC

17- Le diabète insipide central se caractérise par :

- A- Syndrome polyuro-polydipsique hypotonique
- B- Syndrome polyuro-polydipsique hypertonique
- C- Déficit en ADH
- D- Excès d'ADH
- E- Absence de réponse du rein aux hormones antidiurétique

REP: AC

18- Le syndrome tumoral hypophysaire détermine :

- A- Modification au niveau du fond d'œil
- B- Altération du champ visuel par compression du lobe occipital
- C- Hypertension intracrânienne
- D- Compression du 3ème ventricule
- E- Paralysie du nerf crânien (III , IX) par expansion vers le sinus sphénoïde

REP: AC

19- Les aspects cliniques suggestifs pour la malignité des nodules thyroïdiens sont :

- A- Sexe Masculin
- B- Sexe Féminin
- C- Augmentation rapide du nodule
- D- Historique familial du cancer thyroïdien
- E- Age inférieur à 50 ans

REP: BCDE

20- Les affirmations suivantes sur les glandes surrénales sont justes :

- A- La zone médullaire comprend une zone glomérulaire
- B- Au niveau de la zone fasciculaire sont sécrétées les glucocorticoïdes
- C- Au niveau de la zone fasciculaire sont sécrétés cortisol et corticostérone
- D- Au niveau de la zone réticulaire sont sécrétées les androgènes
- E- La zone glomérulaire représente le siège de formation des adrénalines et noradrénalines

REP: BD

21- Localisation des fractures ostéoporotiques :

- A- Fractures vertébrales par entassement
- B- Fracture du col fémorale
- C- Fractures de l'os zygomatique
- D- Fractures du 1/3 distal de l'avant-bras
- E- Fractures de 1/3 distal de l'os claviculaire

REP: ABD

22- L'ostéoporose secondaire apparaît dans des contextes suivants :

- A- Immobilisation
- B- Quelques affections rénales
- C- Affections gastro-intestinale avec malabsorption
- D- Postménopause
- E- Hyperthyroïdie

REP: ABCE

23- L'étiologie des insuffisances surrénales périphériques comprend :

- A- La tuberculose
- B- Le kétoconazole
- C- L'hyperplasie congénitale des surrénales
- D- Les infections
- E- L'adénome hypophysaire

REP: ABCD

24- Le traitement dans hyperparathyroïdie inclut :

- A- Hydratation adéquate avec augmentation de l'apport de vitamine D et du calcium
- B- Administration du diurétique de l'anse
- C- Calcitonine
- D- Progestérone
- E- Estrogène

REP: AB

25- Les manifestations chroniques de l'hyperthyroïdies déterminent :

- A- Caractères de type endocrinien , souscapulaire
- B- Trouble trophique du système dentaire
- C- Tégument chaude et humide
- D- Baisse de la densité osseuse
- E- Augmentation de la densité osseuse

REP: BD

26- Dans le syndrome de l'insuffisance hypophysaire , le déficit corticotrope (ACTH) détermine :

- A- Anorexie
- B- Hypotension artérielle
- C- Pâleur
- D- Mélanodermie
- E- Diminution de la pilosité axilo-pubienne

REP: BCE

27- Les aspects échographiques suggestives à la malignité des nodules thyroïdiens sont :

- A- Lésion hypoéchogène
- B- Contour irrégulier
- C- La présence des microcalcifications
- D- Présence d'un halo
- E- Vascularisation centrale

REP: ABCE

28- Un adénome autonome thyroïdien :

- A- Touche prédominant le sexe féminin
- B- Touche prédominant le sexe masculin
- C- Se manifeste cliniquement par hyperthyroïdie
- D- Se manifeste cliniquement par une légère hypothyroïdie
- E- Associe souvent une ophtalmopathie

REP: ACE

29- Le traitement médicamenteux en acromégalie est représenté par les suivantes :

- A- Agonistes dopaminergique (Octreotid , Lanreotid)
- B- Analogue de somatostatine
- C- Antagoniste dopaminergique (bromocriptine,cabergoline)
- D- Antagoniste du récepteur de GH
- E- Agonistes du récepteur de GH

REP: BD

30- Le diagnostic différentiel de l'hyperthyroïdie de fait avec :

- A- Syndrome néphrotique
- B- Syndrome néphritique
- C- Dépression
- D- Insuffisance rénale chronique
- E- Insuffisance hépatique

REP: ACD

31- Manifestation clinique de l'hyperprolactinémie chez la femme inclut :

- A- Galactorrhée
 - B- Aménorrhée
 - C- Infertilité
 - D- Augmentation de libido
 - E- Cycles menstruelle régulier
- REP: ABC

32- La sécrétion neurohypophysaire inclue :

- A- PRL
 - B- Ocytocine
 - C- ACTH
 - D- TSH
 - E- Vasopressine
- REP: BE

33- Dans l'hyperparathyroïdie primaire les manifestations cardiovasculaires sont représenté par :

- A- Hypotension artérielle
 - B- Hypertrophie ventriculaire gauche
 - C- Hypertension artérielle
 - D- Tachycardie
 - E- Arythmie extrasystolique
- REP: CDE

34- Le diagnostic étiologique du syndrome Cushing comprend :

- A- L'échographie
 - B- La tomodensitométrie abdominale
 - C- La résonance magnétique
 - D- L'IRM hypophysaire
 - E- La scintigraphie surrénalienne
- REP: ABD

35- Au niveau de l'appareil cardiovasculaire dans l'hyperthyroïdisme , apparait les manifestations suivantes :

- A- Bradycardie
 - B- Flutter atrial
 - C- Insuffisance cardiaque
 - D- Péricardite
 - E- Tachycardie sinusale
- REP: BCE

36- l'hypercalcémie tumorale :

- A- Est produit par ostéolyse
 - B- Est causé par la sécrétion de PTH RP
 - C- A comme signe clinique neuropsychique la céphalée
 - D- Est causé par les néoplasies des ovaires
 - E- A comme cause le cancer de larynx
- REP: BC

37- les hypoparathyroïdies peuvent être :

- A- Post opératoire
- B- Idiopathique
- C- Enzymatique
- D- Primitive
- E- Secondaire

REP: AB

38- Les symptômes rencontrés dans le syndrome sheehan sont les suivants :

- A- Phénomène de déssexualisation
- B- Absence de l'installation de la sécrétion lactaire postpartum
- C- Hypertrichose
- D- Réduction de la libido
- E- Aménorrhée

REP: BE

39- Les explorations de laboratoires et paracliniques dans l'hypoparathyroïdie indique :

- A- PTH réduit
- B- Phosphatase alcaline augmenté
- C- Phosphorémie diminué
- D- Calciurie élevée
- E- Calcium ionique diminué

REP: AE

40- Exploration du laboratoire de la maladie de basedow n'indique pas :

- A- TSH bas
- B- FT4 , FT3 élevée
- C- TSH élevé
- D- Cholestérol élevé
- E- Glycémie élevé

REP: CD

41- Les carcinome médullaire thyroïdien présente les caractéristiques suivantes :

- A- Est néoplasme a cellules C
- B- Apparaît habituellement dans la 6ème ou 7ème décennie de la vie
- C- Dans les cas avancés peuvent envahir la trachée et l'œsophage
- D- Présente des cellules Hurthle
- E- La présence de l'amyloïde est caractéristique

REP: ACE

42- les facteurs de risques génétiques dans l'ostéoporose sont :

- A- Fumer
- B- Race asiatique
- C- Antécédents familiaux de l'ostéoporose
- D- Sexe féminin
- E- Apport réduit de calcium

REP: BCD

43- Les signes cliniques mineurs de la maladie de basedow sont :

- A- Tachycardie
- B- Exophtalmie
- C- Goitre
- D- Tremblement des extrémités
- E- Baisse pondérale

REP: DE

44- Les effets secondaires de biphosphonate sont les suivants :

- A- Erosions œsophagiens
- B- Syndrome DRESS
- C- Céphalée
- D- Hypocalcémie
- E- Syndrome pseudo-grippale

REP: BCDE

45- Sécrétion élevée du PTH au niveau rénal détermine :

- A- Hypo phosphaturie
- B- Hypercalcémie
- C- Néphrocalcinose
- D- Augmentation de l'élimination urinaire de H⁺
- E- Hypercalciurie

REP: BCE

46- La thyroïdite de Hashimoto :

- A- Est d'origine auto-immune
- B- A comme élément essentiel le goitre douloureux
- C- Est due à une infiltration de la thyroïde par les leucocytes
- D- Est précédée d'un syndrome grippal
- E- Est caractérisé par la présence des anticorps anti-péroxydase

REP: ACE

47- Les effets hormonaux de l'excès de cortisol sont : ??

- A- Pas d'inhibition de la fonction normale de l'axe hypothalamo-hypophysaire
- B- Inhibition de la sécrétion de GH
- C- Chez les femmes – acnés et hirsutisme
- D- Chez les hommes – inappétence et aménorrhée
- E- Détermine excès des androgènes

REP: C ??

48- Lesquelles représentent les effets secondaires de la corticothérapie chronique : ??

- A- Dépression
- B- Gastrite
- C- Hypocholestérolémie
- D- Ulcère cornéen
- E- Hypotension artérielle

REP: AB (D=> cataracte et glaucome)

49- Les signes spécifiques de la maladie de Basedow sont :

- A- Myxœdème préti**b**iale
- B- Exophtalmie
- C- Myxœdème généralise
- D- Goitre homogène , vasculaire
- E- Bradycardie

REP: ABD

50- Les affirmations correctes sur le score T au test DEXA dans la classification OMS pour la densité osseuse sont :

- A- Score T entre -1 et +1 os normal
- B- Score T entre -1 et -2 ostéopénie
- C- Score T entre -1 et -2,5 ostéopénie
- D- Score T moins de -2,5 ostéoporose
- E- Score T moins de -2 ostéoporose

REP: ACD